

INFILTRACIÓN EN HOMBRO

Patricia Méndez Da Cuña, Vanesa Amores Sierra, Jacinto Rodríguez Albo,

INDICACIONES

La infiltración de hombro es una técnica que consiste en la aplicación directa de principios activos en el hombro patológico.

Los objetivos de la infiltración de hombro son:

- Aliviar o suprimir localmente la inflamación y con ello el dolor.
- Prevenir o recuperar la funcionalidad y la movilidad del hombro.
- Acelerar la recuperación funcional.
- Disminuir, sustituir o eliminar la necesidad de tratamientos más agresivos, contraindicados o con importantes efectos secundarios.

Las indicaciones de esta técnica son:

- Artrosis con inflamación.
- Artritis agudas y crónicas no infecciosas que no responden a tratamiento sistémico.
- Bursitis.
- Tendinitis.
- Tenosinovitis.
- Fascitis

Lo que no se debe olvidar en urgencias:

- No infiltrar más de 3 o 4 veces la misma articulación en 1 año.
- Espaciar 2-3 semanas las infiltraciones para valorar el resultado
- No infiltrar en cada sesión más de 2 articulaciones por la posibilidad de mayor absorción sistémica.

Las contraindicaciones de la infiltración del hombro son las siguientes:

Contraindicaciones absolutas	Contraindicaciones relativas
Sospecha de artritis séptica	Trastorno de la coagulación o tratamiento anticoagulante
Infección sistémica o infección cutánea en el lugar de la infiltración	Diabetes mellitus mal controlada
Inestabilidad articular	Hemartrosis
Fractura intraarticular	Prótesis u osteosíntesis
Placa de psoriasis en el punto de infiltración	Embarazo
Alergia o hipersensibilidad de los fármacos utilizados	Haber realizados infiltraciones previas sin efectos beneficiosos

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

Explicar al paciente la técnica, los beneficios y las posibles complicaciones.

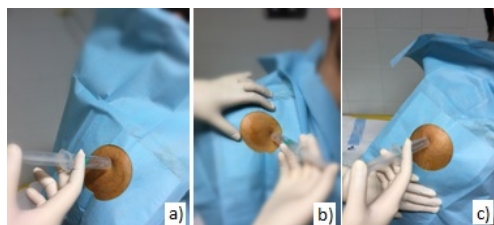
Los pasos a seguir son:

- Colocar al paciente en una posición cómoda.
- Explorar y marcar el punto de entrada de la aguja.
- Asepsia de la zona con povidona yodada y alcohol 70%

- Cargar la jeringuilla con el medicamento: primero corticoide y luego el anestésico.
- Lavado de manos y colocación de campo y guantes estériles.
- Se realizará la infiltración
- Compresión de la zona para evitar sangrados.

Las diferentes vías de infiltración del hombro son:

- **Posterior:** se realiza 1cm por debajo del extremo externo del acromion. La aguja se dirige de forma perpendicular al plano cutáneo, en sentido anterior hasta la apófisis coracoides.
- **Anterior:** el punto de entrada se localiza por debajo de la apófisis coracoides. La dirección de la aguja es perpendicular al plano cutáneo, entre la cabeza humeral y la glena.
- **Lateral:** 1cm por debajo del extremo lateral del acromion, en el surco acromiohumeral, en sentido ligeramente ascendente. Si se introduce la aguja hasta la mitad podemos llegar a la bolsa subacromial y si se introduce entera, infiltraremos el supraespinoso.
- **Articulación acromioclavicular:** con el brazo en posición neutra, se localiza la línea articular y se introduce la aguja.
- **Corredora bicipital:** en el caso de tendinitis, se infiltra el tendón con el brazo en abducción y ligera rotación externa.



Vías de infiltración del hombro: a) posterior; b) anterior; c) lateral.

MATERIAL PARA DESARROLLAR LA TÉCNICA

Material para realizar una infiltración. Fig.2.

- Jeringas 5cc, agujas intramusculares (verdes) o espinales (18-22).
- Guantes, gasas y paños estériles.
- Antisépticos: povidona yodada, alcohol 70º
- Fármacos:
 - Corticoides:
 - Triancinolona Acetónido (Trigon depot®): 40mg
 - Betametasona Acetato (Celestone cronodose®): 6mg
 - Anestésicos locales:

Nombre	%	Comienzo	Duración
Lidocaína	1-2	1-2 min	1 h
Mepivacaína	1	2-5 min	1-2 h
Bupivacaína	0.25-0.50-0.75	5 min	3-5 h
Ropivacaína	0.2	5 min	3-5 h

- Dosis: normalmente se utiliza 1 ampolla de corticoide y 1 ampolla de 2ml de anestésico local.



Material empleado para desarrollar la técnica.

BIBLIOGRAFÍA

- Rivero Franco I, Navarro Massip L. Infiltraciones (I). Infiltración del hombro doloroso. AMF 2010;6(2):83-87.
- Rodríguez Alonso JJ, Fahandez-Saddi H, Flórez García M, Gracia Santos J, Gómez Gómez B, Holgado Catalán S et al. Traumatología de partes blandas. AMF 2008;4(5):244-52.
- Lizan Tudela L, Balanzá Garzón A. Guía de actuación en atención primaria. Barcelona: Semfyc; 2006. p. 1746-52.